

20 - 01-cancer du col utérin - Pr. Aboulfalah

Le premier cours sera consacré au cancer du sang, au cancer du col utérin. On va parler par la suite du dépistage du cancer du col utérin, avec le principe de la prévention en particulier par la vaccination. Le cancer du col représente le deuxième cancer féminin à l'échelle mondiale.

Il vient après le cancer du sang. Actuellement, il est considéré comme une maladie sexuellement transmissible parce que dans plus de 98 % des cas, ce cancer serait lié directement à l'HPV. Parmi les critères de l'OMS pour le dépistage d'une maladie, c'est la maladie type pour la dépister.

C'est un cancer qui est dépistable par des moyens faciles. On pourra éviter le cancer invasif dans pas mal de cas si on adopte une politique de dépistage. Malheureusement, dans notre contexte, c'est une maladie qui reste le plus souvent découverte à un stade beaucoup plus avancé.

Normalement, on ne doit plus avoir de cancer du col à ce stade avancé vu les moyens de dépistage, de détection et même de prévention par la vaccination. C'est aussi une maladie qui est gentille parce qu'elle est radiosensible. Elle est très sensible à la radiothérapie, surtout avec la radiochimie concomitante et aussi par la chirurgie.

Pour la prise en charge, on a trois moyens disponibles. C'est la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. On verra les indications de chacune des méthodes en fonction essentiellement du stade de la maladie.

Mais comme je viens de dire, dans notre contexte, dans les pays en voie de développement, c'est une maladie qui reste très fréquente et souvent découverte à un stade avancé. Dans notre pays, on doit lutter sur ce retard diagnostique parce qu'il affecte directement le pronostic de la maladie. On va adopter le plan suivant.

On va faire des rappels et après on verra sur le plan clinique, mais surtout le bilan d'extension et le bilan pré-thérapeutique avec les moyens thérapeutiques et leurs indications. Je vous rappelle que sur une coupe frontale de l'appareil génital féminin, on voit que la tumeur va naître au niveau du col et pour se propager essentiellement latéralement vers les paramètres, c'est pourquoi si on ne découvre pas la maladie à un stade précoce, cet envahissement paramétriel va affecter le passage du surterre à ce niveau-là et souvent encore au Maroc, on découvre du cancer du col suite à une insuffisance rénale obstructive. Encore, on ne fait pas attention parce qu'il y a des patientes qui sont hémodialisées parce qu'ils sont au stade d'insuffisance rénale et on n'examine même pas la patiente pour voir ce qui se passe au niveau du col utérin.

Donc, on a encore des patientes chez qui on découvre le cancer suite à une insuffisance rénale. Au plan sagittal, en fonction de la localisation du cancer au niveau du col utérin, on peut avoir rapidement une atteinte de la vicié et surtout en cas de tumeur postérieure au niveau de la lèvre postérieure, on peut rapidement avoir une atteinte du rectum. Le cancer du col est réputé une

maladie qui est loco-régionale.

Les métastases surviennent d'une manière très tardive. Si on fait le diagnostic rapidement dans les stades précoces, souvent la maladie est localisée au niveau du col et au niveau du pelvis et on peut agir efficacement sur le plan thérapeutique pour améliorer le pronostic. C'est aussi une maladie qui est très lymphophile, c'est-à-dire que la dissémination peut se faire rapidement par voie lymphatique.

C'est pourquoi il faut avoir une idée sur les groupes ganglionnaires qui peuvent être affectés par la dissémination métastatique, en particulier au niveau du col. C'est surtout la chaîne iliaque externe, la chaîne iliaque interne, puis la maladie ne se propage pas directement et il n'y a pas de saut de relais. C'est-à-dire que la maladie va commencer toujours par atteindre les groupes iliaque externe ou iliaque interne.

En cas d'atteinte, c'est à ce moment-là qu'il peut affecter le groupe iliaque primitif, voire le lombo aortique. Donc c'est une dissémination de proche en proche. On dit que dans le cancer du sein, il n'y a pas de saut de relais.

C'est fait étape par étape. C'est pourquoi avant, on faisait le curage lombo aortique et le curage pelvien en même temps. Actuellement, on sait que si on fait le curage au niveau iliaque, et c'est négatif, on sait que dans plus de 95% des cas, il n'y a pas d'atteinte lombo aortique.

C'est quelque chose de capital de connaître le drainage lymphatique de l'utérus. Sur le plan épidémiologique, comme je viens de dire en introduction, c'est le deuxième cancer féminin à l'échelle mondiale. Vous avez des variations géographiques très importantes.

Dans les pays développés où la politique de dépistage et de prévention est institutionnalisée, on aura moins de cancers et même la disparition quasi complète du cancer dans les pays nordiques, par exemple, parce qu'ils font le dépistage par le flottis, par l'HPV, et ils vaccinent les jeunes filles, même actuellement les jeunes garçons. On arrive à éradiquer même ce cancer-là. Il devient quelque chose d'exceptionnel dans les pays développés qui ont une politique de dépistage et de prévention de ce cancer.

Dans les pays en voie de développement, c'est presque 30 à 75 pour 100 000 comme prévalence. Dans les pays occidentaux, c'est 17 à 18 pour 100 000. Mais comme j'ai dit, même dans les pays occidentaux, il y a une forte disparité entre les différents pays.

Les meilleurs sont les pays nordiques. C'est l'incidence la moins élevée. En Australie aussi, mais dans les autres régions de l'Europe, ça dépend de la couverture en termes de dépistage et en termes de vaccination.

Par exemple, en France, on n'arrive pas à aller au-delà de 40 % de dépistage dans nos populations. C'est pourquoi cette incidence reste un peu élevée par rapport aux autres pays. Il y

a aussi une variation dans le temps.

Il y a une diminution de l'incidence dans le temps. Quand j'étais étudiant, c'était le premier cancer de la femme au Maroc. Je parle du Maroc.

C'était le premier cancer. Maintenant, c'est le deuxième après le sein. Mais ce n'est pas parce que la prévalence du cancer du cœur a diminué, c'est juste que c'est le cancer du sein qui a augmenté en termes de fréquence.

Mais la prévalence reste la même au Maroc parce qu'il n'y a pas de politique de dépistage efficace. Là, je suis revenu. C'est entre 40 et 60 ans, mais il peut toucher n'importe quel âge.

On a des cancers chez des femmes très jeunes parce que des fois, il y a de l'HPV très agressif et la tumeur évolue rapidement. On a même observé des cancers du cœur chez des filles de 19 ans et surtout des filles qui se marient tôt ou qui ont des rapports sexuels très tôt à 11 ans, 12 ans. Vous imaginez rapidement, si elle est atteinte par l'HPV, on peut avoir une évolution et à l'âge de la vingtaine, on peut avoir un cancer du col.

De même, au Maroc, souvent, dans la simbiologie, vous allez regarder dans les bouquins, les météorologies post-ménopausiques, le premier diagnostic que vous allez tous dire, c'est le cancer de l'endomètre. Dans notre contexte, c'est le cancer du col. Donc, il faut continuer à examiner le col parce que c'est ce qui se passe.

Une femme ménopausée qui saigne, on va faire une échographie pour voir l'épaisseur de l'endomètre et on ne va pas penser au col, alors que, malgré un âge avancé, dans notre contexte, l'étiologie la plus fréquente reste le cancer du col parce qu'on est dans un pays à forte prévalence. Donc, souvent, je posais ces questions-là. Le premier diagnostic de cancer de l'endomètre chez une femme qui saigne, il faut évidemment éliminer un cancer du col en regardant, en faisant l'examen sous spéculum.

Si l'examen sous spéculum est normal, c'est à ce moment-là que le cancer de l'endomètre devient le premier cancer à évoquer chez la femme ménopausée. Mais même la femme ménopausée, le cancer du col demeure fréquent. Alors, quels sont les facteurs de risque ? On ne parle plus de facteurs de risque, on parle de l'agent étiologique parce qu'on sait actuellement que c'est l'HPV qui entraîne le cancer du col.

Donc, on n'en discute plus. Et puis, vous allez trouver toujours dans les bouquins et tout ça, qu'il y a des facteurs de risque qui sont là, mais c'est des facteurs de risque en fait d'infection par le HPV. D'accord ? Donc, quand on parle de précocité des rapports, les partenaires multiples, les grossesses multiples, les mauvaises conditions hygiéno-diététiques, le tabac, tous ces facteurs-là favorisent l'infection par l'HPV et par la suite, c'est l'HPV qui va conduire au cancer du col utérin.

Donc, si je pose la question quel est le facteur de risque le plus important, en fait, c'est l'HPV. D'accord ? C'est un facteur en fait causal. Et puis, vous avez des facteurs favorisant l'infection par l'HPV, mais le cancer du col est lié à l'HPV.

Alors, vous allez voir tout ça, mais il y a un autre facteur qui est très, très important dans l'augmentation, si vous voulez, de l'incidence du cancer du col. Je dis que l'HPV, c'est le facteur causal. Et le deuxième facteur, vous avez une idée qui peut répondre, il y aura deux points de plus, quatre points de plus.

Ce n'est pas marqué ici, mais vous pouvez le trouver facilement. Oui. Donc, c'est l'absence de... Oui, exactement.

C'est l'absence de vaccination et de dépistage. D'accord ? Le fait de ne pas aller chercher l'HPV pour le prendre en charge correctement, ne pas faire de frottis, on ne va pas découvrir ces lésions pré-cancéreuses et du coup, on va avoir plus de cancers invasifs. Donc, un, si je vous pose la question, deux facteurs déterminants dans le cancer du col, si je mets tout ça, en fait, c'est l'absence de dépistage et l'HPV.

Ça, c'est un cadeau pour le présent, ne vous dites pas ça aux absents. Donc, les deux facteurs déterminants dans l'incidence, c'est l'infection par l'HPV. Deuxièmement, l'absence de politique de dépistage et de vaccination.

Alors, c'est très important sur le plan clinique de savoir que toutes les myoplasies du col naissent à partir de la zone de jonction. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la métaplasie, l'endocole qui va sortir et sera remplacée par l'exocole. Donc, c'est une zone en concentre romaniément histologique et c'est la zone la plus fragile.

Et du coup, c'est la zone qui sera en premier infestée par l'HPV et à ce niveau-là que l'HPV va commencer à faire des altérations cytonucléaires au niveau de la zone de jonction. Donc, toutes les myoplasies naissent à ce niveau-là. C'est quelque chose de très important.

C'est pourquoi, quand on veut faire un prélèvement, par exemple, cytologique, il faut que ce prélèvement concerne la zone de jonction. Et pour savoir qu'il a concerné la zone de jonction, qu'est-ce qu'il faut avoir sur la lame? Les deux types de cellules. Il faut avoir les cellules endocervicales et exocervicales pour dire que le prélèvement a concerné la zone de jonction.

Et puis, quand on veut faire la colposcopie, c'est l'examen binoculaire du colutérin après l'application d'acide acétique ou du Lugol. Alors, si on ne voit pas la zone de jonction, on ne peut pas éliminer un cancer. Donc, toutes les investigations doivent concerner la zone de jonction.

Quand on fait la première des choses au cours d'une colposcopie, c'est de voir la zone de jonction. Si on n'a pas pu voir la zone de jonction, surtout chez les femmes ménopausées, parce que la zone de jonction a tendance à remonter vers le canal cervical, on ne peut pas éliminer un

cancer. On dit que la colposcopie est non concluante du fait que la zone de jonction n'est pas visible.

C'est quelque chose de capital de savoir que la majorité des cénéoplasies naissent au niveau de la zone de jonction et que toutes les investigations doivent concerner cette zone de jonction. Sur le plan macroscopique, c'est souvent des tumeurs bourgeonnantes exophytiques ou des ulcérations au niveau du col ou des fois vous avez des lésions ulcéraux bourgeonnantes. Au moment où on voit une lésion cervicale, il faut faire la biopsie directement.

Il ne faut pas demander de froter l'erreur fatale. Souvent, les médecins généralistes et même les gynécologues vont faire un frottis au lieu de faire la biopsie. Alors des fois, vous avez de l'infection, vous avez de la nécrose à ce niveau-là et quand vous faites le frottis, on risque de ne pas avoir de cénéoplasie qui sera un frottis négatif alors qu'il y a un vrai cancer.

C'est pourquoi toute lésion au niveau du col doit être biopsiée. On ne fait pas de frottis ou de colposcopie ou de l'HPV. Il faut faire la biopsie directement.

Au plan microscopique, le type histologique le plus fréquent dans plus de 90% des cas c'est le cancer épidermoïde, kératinisant ou non-kératinisant. Bien évidemment, l'endopathologiste va vous donner le grade soit bien ou moyennement différencié ou très peu différencié. On va voir tout à l'heure qu'à partir de l'HPV, il y a des lésions dysplasiques qui peuvent être de bas grade et qui peuvent évoluer de lésions de haut grade pour arriver à un carcinome in situ où la membrane basale est toujours respectée.

Et puis on commence à avoir de la micro-invasion. En fonction de la profondeur de l'invasion et en fonction de l'invasion en surface, on va définir par la suite le cancer invasif. Et puis vous avez l'adénocarcinome.

L'adénocarcinome touche essentiellement le canal cervical. Et on pensait avant que l'épidermoïde, c'est celui qui était lié directement à l'HPV. Et on sait actuellement que même l'adénocarcinome est lié à l'HPV.

Et puis vous avez toutes sortes de carcinomes, carcinomes circulaires, les sarcomes, les mélanomes peuvent aussi, c'est des tumeurs rares qu'on peut retrouver au niveau du col utérin au moment de la biopsie. Alors les modalités d'extension de ce cancer, donc j'ai dit au début que c'est un cancer loco-régional, c'est-à-dire son développement reste longtemps au niveau du col et au niveau du pelvis avant l'apparition des métastases. C'est pourquoi même si on ne fait pas le dépistage pour éviter le cancer, le fait de détecter précocement la néoplasie peut transformer le pronostic.

Donc même en faisant la détection précoce du cancer, peut améliorer d'une manière radicale le pronostic. Alors souvent il y a des remarques quand je parle de dépistage et de la détection précoce, les gens confondent les deux. Ce n'est pas la même chose.

Le dépistage, c'est que la patiente n'a rien du tout. Donc je vais convoquer à l'échelle nationale toutes les femmes après le rapport sexuel et je vais faire soit un test HPV, soit un frottis. Alors que l'examen est strictement normal.

Dans la détection précoce, ce n'est pas un dépistage, c'est juste qu'on va examiner toutes les femmes par l'examen sous spiculome et éventuellement en appliquant l'acide acétique sur le col pour sensibiliser l'examen et on va faire des biopsies sur les ongles qui blanchissent. La détection précoce, parce qu'on va voir tout à l'heure l'inspection visuelle après l'acide acétique, c'est l'IVA, c'est de la détection précoce, ce n'est pas un dépistage. C'est qu'on va chercher un cancer à un stade précoce.

Ça peut être un cancer pré-invasif ou invasif, mais à un stade précoce. C'est ça la détection précoce, ce n'est pas le dépistage. Si je dis la détection, le dépistage, les deux moyens, c'est le frottis et le test HPV.

L'IVA, l'inspection visuelle à l'acide acétique, c'est une détection, c'est un moyen de détection précoce, pas un moyen de dépistage. Je vous dis ça parce qu'au Maroc, quand on n'a pas pu faire le dépistage correctement par le frottis et par le test HPV parce que ça coûte plus cher pour l'État, on a fait une solution intermédiaire, c'est d'installer des centres partout et les femmes vont venir et on va les examiner sous spiculum et après application d'acide acétique, c'est ce qu'on appelle l'IVA. C'est un moyen plutôt de détection précoce de myoplasie qu'un moyen vrai de dépistage.

Les modalités d'extension, les myoplasies naissent toujours de la zone de jonction entre les muqueuses cylindriques endocervicales et l'épithélium stratifié, l'exocol. Une notion capitale, c'est qu'entre l'infection par l'HPV et l'apparition d'un vrai cancer invasif, c'est une durée très longue. Ça peut aller jusqu'à 10 ans.

C'est pourquoi le dépistage est quelque chose de formidable, parce qu'au moment où il y a des altérations au niveau cellulaire, on peut toujours se rattraper avant l'invasion. Vous avez l'infection par l'HPV, dans 80% des cas, cette infection va disparaître, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'HPV, ça n'existe pas. Vous allez trouver partout des trucs, c'est n'importe quoi.

Il n'y a pas d'antivirus, ils ne sont pas actifs sur l'HPV. Mais dans 80% des cas, ces lésions vont régresser, voire disparaître. Mais dans 20% des cas, ces lésions vont passer de lésions de Bagraade, puis des lésions de Haugrade, voire des lésions invasives.

Mais le moment où l'apparition de l'infection par l'HPV jusqu'à l'apparition du cancer invasif, ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi on a le temps de dépister, de diagnostiquer ces lésions pré-cancéreuses et de les traiter correctement afin d'éviter d'éradiquer l'évolution vers l'invasif. Il y a une diffusion hépatélie.

Souvent, il y a une atteinte du vagin. Cette atteinte se fait de proche en proche. On parle de

diffusion hépatélie vers le vagin en bas et vers l'utérus en haut.

Puis vous avez la diffusion lymphatique. C'est un cancer qui est très lymphophile et qui va suivre en latéral les paramètres, les vaisseaux lymphatiques à ce niveau-là, avec les premiers relais ganglionnaires au niveau essentiellement du groupe iliaque externe avec les trois chaînes, la chaîne latérale, la chaîne interne et l'interne entre l'artère et la veine, la chaîne médiane. Mais c'est surtout la chaîne interne appelée aussi sous-veineuse parce que vous avez l'artère dehors et vous avez la veine dedans au niveau des vaisseaux iliaques.

Alors cette diffusion au niveau des paramètres, s'il atteint les urtères, il va comprimer les urtères et il va être responsable d'une urétéro-hydronéphrose. C'est pourquoi dans le bilan de l'urétéro-hydronéphrose, il faut obligatoirement chercher un cancer pelvien, en particulier un cancer de l'utérus. Alors si on ne fait pas le diagnostic à ce moment-là, on peut avoir une atteinte visicole, en particulier au niveau des trigones, parce que c'est à ce niveau-là où les urtères arrivent, et on peut avoir une atteinte de méas urétéraux.

Et en arrière on peut avoir une atteinte de rectum, mais il faut savoir que quand vous dites à la patiente ça fait combien de temps qu'il saigne, il va vous dire au moins un an ou deux ans d'évolution pour arriver à une atteinte rectale ou visicole. Donc c'est un cancer qui est gentil, on peut soit le dépister, soit au moins faire une détection précoce de stade précoce, parce que le pronostic est radicalement différent par rapport à une atteinte au niveau du stade 1 localisé au niveau du col, par rapport à un cancer qui a déjà une atteinte soit de la viscose, soit de rectum ou des métastats. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cancer qui est très lymphophile et il se propage de proche en proche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais ganglionnaires.

Et le groupe le plus concerné, c'est essentiellement l'iliac externe. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement on commence à faire le ganglion sentinelle, c'est qu'on va localiser le premier relais ganglionnaire qui draine le col et on va enlever ce ganglion et on va faire l'étude histologique. S'il n'y a pas d'atteinte au niveau de ce ganglion relais, on dit qu'il n'y a pas d'atteinte lymphatique.

S'il y a une atteinte de ce ganglion relais, on suppose qu'on peut avoir d'autres atteintes ganglionnaires, c'est le principe du ganglion sentinelle. C'est pourquoi il faut savoir là où il faut aller chercher le ganglion sentinelle. Et puis, pour un site beaucoup plus avancé, on peut avoir l'atteinte en haut vers l'iliac primitif et même l'emboi orthique.

Et puis, dans certaines situations, on peut avoir une atteinte au niveau du ganglion de promontoire présacré et des fois une atteinte inguinale. Quand vous avez une atteinte des deux tiers inférieurs du vagin qui sont aussi drainées par le groupe inguinal, donc on peut avoir des métastases inguinales. Mais c'est essentiellement l'apanage des cancers qui peuvent être découverts à un stade avancé.

L'extension métastatique, les métastases parfois sanguines ou lymphatiques, c'est toujours les

cancers à un stade avancé. C'est quelque chose d'exceptionnel. Personnellement, je n'ai jamais vu un cancer stade 1 avec des métastases.

C'est pourquoi c'est quelque chose de très important d'essayer de faire le diagnostic précoce du cancer du col parce que ça change radicalement la survie. Un stade avancé, on peut avoir les localisations métastatiques les plus fréquentes, c'est le foie, l'os et le poumon. C'est exceptionnellement qu'on va découvrir un cancer du col suite à la découverte d'une image pulmonaire ou hépatique si souvent on fait le diagnostic du cancer avant ces métastases.

Les métastases inaugurales d'un cancer du col, moi je n'ai jamais vu ça. C'est pour vous dire l'importance du diagnostic précoce. Et puis souvent ces métastases, on les observe quand la patiente ne répond plus à la radiochimiothérapie.

C'est à ce moment-là qu'une évolution qui se fait d'une manière obligatoirement c'est la mort, parce que c'est des patients qui ne répondent plus à la chimiothérapie et ces métastases vont tuer la patiente dans les six mois qui suivent l'apparition des métastases. On va parler tout d'abord sur le plan clinique du dépistage. Mais normalement dans notre contexte, on doit parler des signes fonctionnels, parce que c'est la situation réelle malheureusement encore au Maroc.

Mais ce qui se passe dans les pays développés, c'est que c'est exceptionnellement qu'une femme qui saine va venir consulter le médecin et on va découvrir le cancer du col. Ce sont des femmes chez qui on a fait des frottis, on a trouvé des altérations cellulaires au niveau des frottis, on va faire la biopsie et ça sort un cancer invasif ou micro-invasif. C'est pourquoi l'idéal c'est d'avoir le diagnostic par ces moyens-là de dépistage et des fois quand le dépistage est mal fait ou il n'est pas régulièrement bien fait, on peut avoir quand même des cancers invasifs, mais après une évolution, on n'a pas pu rendre ce cercle avant l'apparition de l'invasion.

Alors pour le dépistage, actuellement c'est deux moyens, le plus classique qui est connu depuis des décennies, c'est le frottis et le deuxième moyen, actuellement on préfère le test HPV au lieu du frottis, mais je vais vous dire pourquoi. Concernant le frottis, surtout la place du médecin généraliste, c'est quelque chose de très important parce que ce dépistage, il faut dépister le maximum de patients pour que le dépistage soit efficace. Au moins, il faut qu'il touche une population de moins 60% de la population féminine.

Alors ce frottis, il est fait en deuxième partie du cycle à distance des rapports, mais ça c'est ce qui est classique. Mais pour moi, si une dame qui consulte pour autre chose, c'est toujours une occasion d'aller faire un frottis. C'est rarement une femme marocaine qui va voir le médecin juste pour faire son frottis, ce n'est pas l'habitude encore chez nous, mais à chaque fois qu'il y a une occasion où la femme consulte même pour autre chose, il faut lui proposer un frottis.

Donc le frottis conventionnel, avec les spatules, on prélève, on étale et on fixe au niveau de la lame. C'est le test de Papa Nicolaou. C'est presque remplacé par le frottis en milieu liquide parce

que là, c'est très simple, on va rendre le frottis ininterprétable ou non significatif par le frottis en milieu liquide.

Donc on fait juste une brosse, on l'introduit au niveau de l'endocolle, on fait le tour et on dépose la brosse au niveau d'un flacon où il y a un milieu pour la fixation et on envoie à la cytologie. Donc c'est beaucoup plus intéressant que le frottis conventionnel, c'est un tout petit peu plus cher, mais il est beaucoup plus efficace que le frottis conventionnel. Le frottis conventionnel, quand on le prélève, il y a de la glaire, il y a des cellules mortes et tout ça.

Au niveau du frottis en milieu liquide, il y a une centrifugation du milieu qui va éliminer tout ce qui est nécrose ou de la glaire et tout ça. Donc c'est pourquoi on va avoir une concentration beaucoup plus élevée de cellules afin de faire l'étude correctement. Alors les cytologistes vont répondre en fonction de la classification de Bethesda.

Donc ils vont nous dire que c'est un frottis présence de cellules normales, endo-exo-cervicales. S'ils vous disent qu'il n'y a pas de cellules endo-cervicales, c'est qu'il faut refaire ce frottis, ce qui n'est pas significatif. Et puis ce qu'ils vont nous dire sur ces cellules anormales, c'est que ces cellules anormales, ils vont les grader en fonction de dysplasie de Vagrad ou de dysplasie de Haugrad.

Et des fois qu'il y a de l'incertitude, des frottis non significatifs ou ininterprétables, soit qu'on donne un traitement sur toutes les femmes ménopausées ou en cas d'infection, il faut traiter l'infection, il faut traiter la sécheresse vaginale avant de refaire le frottis. Et puis quand il veut dire frottis et présence de cellules tumorales, là il faut se méfier et ça doit déboucher sur la colposcopie. Tout frottis anormal, présence de cellules suspectes, doit déboucher sur une colposcopie pour repérer la zone anormale et faire la biopsie à ce niveau-là.

Concernant le rythme de dépistage par le frottis, le premier frottis doit être fait dans l'année qui suit le premier rapport, parce que l'HPV c'est une infection sexuellement transmissible. Une fois le premier rapport consommé, dans l'année il faut faire ce frottis, en général souvent il est normal, mais ce sera la base de la surveillance par la suite. Puis on va faire un frottis annuel jusqu'à 35 ans pendant 20 ans et on arrête, si le frottis est normal, le dépistage à 60 ans.

Vous allez me dire, et tout à l'heure vous dites que le cancer du corps peut toucher la femme inopposée, oui, mais c'est juste que ces femmes-là étaient déjà infectées par l'HPV et vu que ça prend beaucoup de temps pour se développer l'infiltrant, à 60 ans, déjà s'il est infecté à 60 ans par l'HPV, ça va durer très longtemps. Donc c'est rarement où la femme inopposée au-delà de 60 ans sera infectée par l'HPV et va développer le cancer par la suite. C'est quand même une situation rare.

Dans la majorité des pays, on arrête le dépistage à l'âge de 60 ans. Depuis les années 90, on sait que le cancer du corps est directement lié à l'HPV. On se dit pourquoi ne pas voir s'il y a une infection par l'HPV ou pas.

S'il n'y a pas d'infection de l'HPV, on est tranquille. S'il y a de l'HPV, on va craindre les altérations cellulaires. À ce niveau-là, on va commencer à faire de la cytologie et même de la colposcopie avec la biopsie.

C'est le test HPV. Le test HPV, en fait, HPV-HR, haut risque. On va chercher les HPV qui sont dits oncogènes ou très oncogènes, pas très haut risque, en particulier le 16 et le 18, qui sont responsables de plus de 80% du cancer du corps.

On fait un prélèvement au niveau du col et par PCR, on va dire qu'elle est positive à tel ou tel stéréotype viral de type à haut risque. Si c'est négatif, c'est bon, on ne fait rien. On convoque la patiente dans cinq ans, on refait un autre test HPV.

Mais s'il est positif, on dit que l'HPV est là, la patiente est infectée par l'HPV, mais est-ce que ce virus a fait des altérations cellulaires ou pas, on ne peut pas le dire. Le test va vous dire présence ou non de l'HPV, et quand l'HPV est positif, c'est à ce niveau-là, on va faire soit le frottis, soit la colposcopie pour voir s'il y a des altérations secondaires à l'HPV ou pas. Actuellement, c'est bien de le savoir, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent pour le test HPV, et quand on découvre l'HPV, on sait qu'elles vont regarder sur Internet si c'est une infection sexuellement transmissible, et ça peut engendrer des problèmes au sein du couple.

Ce qu'il faut expliquer au couple, c'est que l'HPV est partout, on peut le trouver au niveau de la table, sur le microscope, moi je viens d'arriver de la consultation, on peut avoir de l'HPV ici. Donc il faut expliquer au couple que l'HPV est partout, elle est considérée comme une infection sexuellement transmissible parce qu'il y a un vecteur, mais la femme aussi, s'elle fait des toilettes intimes, l'HPV est partout, elle peut être aussi vectrice de l'infection. Donc ça c'est quelque chose de capital, parce que sinon vous allez détruire la relation au sein du couple.

Donc il faut essayer de les convaincre comme quoi l'infection est partout, il y a un vecteur, mais ce n'est pas forcément qu'il a attrapé ça à travers une autre femme. Donc il faut expliquer au couple ce problème pour ne pas engendrer des problèmes sociaux au sein du couple. Alors dépistage ou détection précoce, là c'est par l'inspection visuelle à l'acide acétique, c'est ce qu'on appelle l'IVA, ce n'est pas un moyen de dépistage, c'est un moyen de détection précoce, parce que la lésion elle est déjà là, on va juste la regarder et la biopsier.

C'est un moyen de détection précoce. C'est pourquoi on a toujours des problèmes avec les gens qui n'assistent pas, parce que c'est un gros chapitre sur le dépistage, j'ai mis ça pour vous dire que ce n'est pas un moyen de dépistage, c'est un moyen de détection précoce, l'IVA. Quand il demande la recorection, même si tu lui expliques qu'elle est marquée au niveau du corps, je n'ai jamais dit que c'était un moyen de dépistage, les deux moyens de dépistage c'est le frottis et le test HPV.

Là, on parle parce que c'est une politique adoptée au Maroc, à défaut qu'il n'y ait pas de

dépistage vrai par l'HPV et le frottis, on commence à regarder le col, si il y a une lésion on fait la biopsie, s'il n'y a pas de lésion j'applique l'acide acétique, une zone qui va blanchir, je fais la biopsie à ce niveau-là, c'est ça le principe de l'IVA. Donc test négatif, pas de lésion acidophile, ou qui se blanchissent, c'est ça les lésions acidophiles. Donc c'est ça ce qu'on regarde, l'épithélium endocervical, exocervical et la zone de jonction.

Un test positif, quand vous avez une partie de la muqueuse qui va se blanchir, comme ici, j'applique l'acide acétique et je vois que cette zone est blanche, à ce niveau-là, on dit que le test est positif et je dois faire la biopsie. Et puis avec l'IVA, je peux regarder le col et je vais trouver ces lésions-là. On voit que c'est un cancer invasif, donc là on fait la biopsie directement, c'est pourquoi l'inspection visuelle, c'est en fait, on essaie de diagnostiquer le cancer, mais à un stade précoce.

Alors il y a l'acide acétique, c'est la méthode qu'on utilise souvent, mais aussi on peut utiliser, après l'acide acétique, on peut utiliser aussi le LIGOL, appelé aussi le test Schiller. Un test négatif, c'est l'épithélium pavimenteux devient brun à cajou, celle-là, ne change pas de couleur, c'est un test qui est négatif. Puis vous avez des tests positifs, par exemple ici où il n'y a pas une coloration uniforme et surtout il faut se méfier de la zone de jonction.

Et puis quand vous avez des lésions comme ça, dans plus de 90% des cas, c'est un cancer, un vrai cancer, un cancer invasif. Donc normalement, le cancer doit être découvert après cette étape de dépistage et sinon de détection précoce, mais notre réalité est différente. Donc ce sont des femmes qui vont consulter, parce que soit elles ont des météorologies provoquées, provoquées par les rapports sexuels ou par les toilettes intimes, elles vont venir, si elles sont bien éduquées, sensibilisées, elles vont dire « j'ai fait rapport hier avec mon mari, j'ai trouvé une goutte de sang ». Là, il faut faire l'examen sous spiculum à la recherche d'une lésion qui saigne.

S'il n'y a pas de lésion, c'est l'occasion de faire un frottis. Mais ce qui se passe encore, d'alarmant encore dans notre pays, c'est qu'elle va aller voir le médecin généraliste, eux-mêmes les gynécologues. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire directement l'échographie.

L'échographie, on ne peut pas avoir des lésions cervicales. Donc, elle va continuer à saigner et ce saignement va en devenir permanent. Et elle va changer de médecin, elle va changer de médecin.

Le jour où un médecin fait l'examen sous spiculum, il va trouver le cancer. Elle est là et encore peut-être qu'elle a dépassé le colutérin. Malheureusement, cette réalité, elle est toujours au Maroc.

La faute à la patiente est la faute aussi des médecins. Donc, la lésion, le maître symptôme, c'est les météorologies qui sont d'abord provoquées et qui vont devenir par la suite permanentes. Et puis, là, ça signe toujours que la lésion est déjà invasive.

Parce que les lésions pré-invasives ne saignent jamais. Donc, si la patiente saigne déjà, c'est que le cancer est déjà invasif. Et puis, si on ne fait pas le diagnostic, c'est un cancer, c'est une neuplésie qui va se surinfecter et la patiente va avoir des pertes, des locorées, des pertes vaginales, nauséabondes.

Elle arrive pour vous dire, j'ai des pertes qui dérangent, ça sent. Et quand vous dites, oui, vous saignez. Oui, oui, je saignais depuis deux mois.

Donc là, on sait que ça va être un cancer, mais un stade avancé. Et puis, s'il vous dit, oui, j'ai mal au niveau du pelvis, au niveau de la paroi pelvienne et tout ça. Et vous demandez à la dame, vous avez des pertes, vous saignez.

Oui, on sait que c'est un stade très avancé. Les douleurs n'apparaissent, ça signe toujours un stade avancé. Il n'y a pas de douleur quand vous avez un cancer qui est localisé au niveau du corps.

Les douleurs apparaissent. Quand il y a une infiltration paramétriale avec atteinte des urtères, l'urétéro-hydronéphrose, la patiente va avoir mal. Et on découvre encore des cancers suite à des lombologies.

Et puis, vous avez tous les plexus nerveux derrière et vers la paroi pelvienne. Si le cancer n'est pas découvert à un stade précoce, l'extension peut se faire vers les plexus nerveux. À ce moment-là, la douleur est effroyable.

Alors, bien évidemment, quand il y a un symptôme, en l'absence même de symptôme, toutes femmes qui arrivent en consultation, on doit regarder, c'est l'occasion de regarder le col. On peut découvrir des vrais cancers qui sont totalement asymptomatiques. C'est pourquoi l'examen sous spéculum doit être systématique et obligatoire.

Alors, ce n'est pas toujours évident. Quand la patiente vient pour d'autres symptômes, surtout lorsque le médecin est du sexe masculin, c'est difficile de mettre le spéculum comme ça. Il faut arrêter de faire ça.

Il faut toujours discuter à la dame, de lui dire, voilà, madame, vous êtes venue pour des céphalées, mais c'est une occasion qu'on regarde le col. S'il y a comme ça, s'il y a des lésions qui vont apparaître, on peut le savoir, d'accord ? Donc, ils vont accepter. Mais mettre du spéculum, faire des touches comme ça, sans expliquer à la dame, il y a plein de poursuites dans les pays, en France.

La majorité des grands chefs, ils faisaient ça. La dame arrive, on fait ce qu'on veut. Nous, les médecins, on va la toucher, mettre le toucher rectal, mettre le spéculum.

Ça, c'est actuellement considéré comme une violence envers la femme. Donc, il y a pas mal de poursuites, même au Maroc. Donc, il faut expliquer à la dame qu'est-ce qu'on va faire, quel est le

but de ce que je veux faire.

Le toucher rectal, je peux pas faire le toucher rectal chez toutes les femmes qui vont venir en consultation. Mais s'il a de l'endométriose, s'il a un cancer, je vais lui dire, voilà, je vais faire un toucher rectal parce que l'endométriose peut envahir la cloison, peut envahir le rectum. Pour satisfaire le cancer, on va faire un toucher rectal.

Ils vont accepter sans problème, et il ne faut pas une poursuite médico-légale. Donc, le spéculum, on va regarder le col. Et puis, en sortant, il faut toujours regarder la paroi du vagin.

Je viens de dire, le toucher rectal, il n'est pas systématique, si tu trouves rien, mais bien évidemment, s'il y a un cancer, le toucher rectal, bien évidemment, il va apprécier les relations postérieures et l'atteinte postérieure, en particulier le rectum. Mais surtout, c'est le meilleur moyen pour voir est-ce qu'il y a une atteinte paramétriale ou pas. Donc, c'est un moyen très fiable pour voir l'extension en latérale, associée, bien évidemment, au palpé abdominal, et même, des fois, il est beaucoup plus sensible que les examens paracliniques.

Donc, des fois, on a des IRM qui parlent d'envahissement ou de l'absence d'envahissement, le toucher rectal, si on le fait correctement et on a de l'expérience avec le temps, c'est mieux que les examens paracliniques. Et comme je dis, toute lésion, ce n'est pas le frottis, c'est la biopsie. Toute lésion doit être biopsiée.

Alors, comment on fait le diagnostic positif, c'est-à-dire pour dire que c'est un cancer, donc c'est bien évidemment, c'est toujours l'histologie. On fait le frottis, le test HPV dépiste, la colposcopie et la biopsie, et on fait le diagnostic. La certitude diagnostique est apportée par l'histologie.

Donc, c'est comme l'étude clinique, soit qu'on a fait un frottis, ils parlent de lésions de haut grade, je fais la colposcopie, je vois une lésion, je fais la biopsie, et il va me sortir, soit que c'est un carcinome in situ, microinvasif ou invasif. Donc, normalement, dans une politique de dépistage, c'est dans la majorité des cas, le diagnostic est posé de cette manière. Mais en l'absence de dépistage, la patiente va venir parce qu'il y a une lésion, et je fais la biopsie sous spéculum.

Et puis, dans les lésions précancéreuses, vous faites le frottis, je fais la colposcopie, je fais la biopsie, lésion de haut grade. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une conisation. On va enlever une cône au niveau de la zone suspecte à la colposcopie.

Et puis, cette conisation est faite dans un but diagnostique pour dire qu'il n'y a pas d'invasion, il y a une microinvasion, il y a une invasion, et elle est dans un but thérapeutique aussi. Si on passe en zone saine et il n'y a pas d'invasion, c'est que la patiente a... Je ne fais rien, je garde juste cette conisation. Donc, de temps en temps, quand on fait la conisation, on découvre qu'il y a une invasion au niveau de la pièce de la conisation, et à ce niveau-là, je vais le considérer comme un invasif et le traiter d'une manière appropriée.

Alors, les messages que je voulais vous faire passer, c'est presque 90% de l'objectif du cours. D'accord ? Donc, c'est tout d'abord le dépistage et le diagnostic précoce, il ne faut pas passer à côté, et il faut vraiment faire le maximum, au moins pour faire l'examen suspiculant, parce que ça ne coûte rien du tout, et s'il y a la possibilité de faire un frottis ou de l'HPV. Et puis, vous avez des gens qui font ce qu'on appelle le dépistage combiné, c'est qu'on va faire les deux, le frottis et l'HPV, mais ça coûte cher.

Personnellement, je suis contre, dans un pays à ressources limitées, mais j'ai tendance actuellement beaucoup plus à faire l'HPV, parce que le frottis aussi dépend de la lecture cytologique par le cytologiste ou l'anatomopathologiste. L'HPV, c'est la PCR, le génome viral. Il n'y a pas de marge d'erreur, de grande marge d'erreur.

C'est pourquoi, quand je reçois une patiente qui a l'HPV positive, je vais faire encore plus d'attention pour aller chercher ces petites lésions, ces transformations au niveau cellulaire, mais s'ils me ramènent un frottis comme ça, j'aurai toujours le doute. C'est pourquoi la tendance actuellement, c'est de commencer par le test HPV. Le problème, c'est que l'HPV est très, très fréquent, et dans 80% des cas, il va disparaître seul, et donc on va engendrer un stress chez la patiente, mais aussi une surinvestigation.

On va faire un frottis ou une colposcopie de plus, alors que dans 80% des cas, ce virus va disparaître lui-même. Alors, on a le diagnostic maintenant de cancer invasif, donc il faut faire un bilan d'extension avant de traiter, bien évidemment, cette patiente. Alors, le bilan d'extension, elle est avant tout loco-régional.

Elle dépend de ce que vous allez voir vous-même à l'examen clinique. D'accord ? Ça, c'est l'élément essentiel. Donc, c'est la certification, elle est essentiellement clinique.

Si j'ai une petite tumeur de 1 cm au niveau du col, je ne vais pas demander un scanner thoraco-abdominopelvien ou un PET scanner. C'est de la surconsommation pour rien du tout. Je sais que ce tumeur est localisé.

Mais si je vois qu'il y a une tumeur, une grosse tumeur, le toucher rectal, les paramètres me semblent envahis, là, obligatoirement, il faut pousser les investigations. Donc, les investigations paracliniques, dans le cadre du bilan d'extension, elles reposent, elles sont orientées par les données de l'examen clinique. Alors puis, quel est le premier examen paraclinique que je vais demander ? C'est l'IRM ou, à défaut, le scanner.

Et qu'est-ce que je vais chercher ? Essentiellement, s'il y a une atteinte paramétriale et puis le volume, je dois calculer le volume de la tumeur. Parce que ces deux éléments-là, ils sont très importants pour le pronostic, mais aussi pour les modalités thérapeutiques. Donc, l'IRM est supérieur au scanner pour définir l'extension locale, la taille tumorale, le vagin, les paramètres, la vessie, le rectum et l'atteinte ganglionnaire, iliaque.

Et ses limites, c'est lorsque vous avez une tumeur qui n'est pas bourgeonnant, c'est juste une ulcération et souvent l'IRM va vous montrer, même le scanner, parce que c'est une petite ulcération au niveau du col, on ne va rien voir. Donc, à défaut de l'IRM, on demande le scanner et puis est-ce qu'on demande les examens endoscopiques? Si vous avez une tumeur assez volumineuse au niveau de la lèvre antérieure de la viscille, vous avez une perte de l'israël de sécurité à l'IRM ou au scanner à ce moment-là, on fait une cystoscopie. Si la tumeur est à développement postérieur avec une perte de l'israël graisseux entre l'utérus et le rectum, je fais une rectoscopie pour chercher s'il y a une lésion pour la biopsie.

Et puis vous avez, bien évidemment, l'examen général, surtout quand la tumeur est localement avancée, il faut aller chercher des métastases. Alors, pour les tumeurs localement avancées, on sait qu'il y a un risque aussi important de métastases au niveau pulmonaire, au niveau hépatique et au niveau osseux. La tendance actuellement, c'est qu'on demande un PET scanner pour dépister éventuellement une métastase ou une atteinte gonglionaire, lambeaux, aortique, qui peut être non visible au scanner et à l'IRM.

Donc le PET scanner commence à avoir ses indications, mais surtout pour les stades avancés. La classification, il faut la connaître par cœur aussi. Après ce bilan d'extension qui est clinico-radiologique, souvent on dit que la classification FIGO, c'est une classification clinique.

C'est juste que pour les anglo-saxons, l'imagerie est considérée comme clinique. Donc la classification est radio-clinique. Je parle du concept du col, pas de l'ovaire, c'est autre chose, mais je parle du concept du col, c'est une classification clinico-radiologique.

Donc le stade zéro, c'est le carcinome in situ, il n'y a pas d'invasion, la membrane basale est respectée. Le stade 1, c'est le carcinome qui est limité au col. Et là, le stade 1A, il est presque toujours diagnostiqué suite à des investigations secondaires ou d'épistage avec corposcopie et biopsie.

C'est à ce niveau-là qu'on va trouver le stade 1A en fonction de la profondeur de la lésion. Donc c'est un diagnostic toujours histologique. 1A, invasion du stroma, 3 mm est inférieur à 3 mm et inférieur à 7 mm en surface.

Horizontalement, c'est en surface. Le 1A2, c'est l'invasion du stroma en profondeur. Le stroma, c'est en profondeur.

Horizontalement, c'est en surface. Il se situe entre 3 à 5 mm, mais toujours inférieur à 7 mm en surface. Et puis vous avez le stade 1B, tumor localisé au niveau du col.

Par la suite, on a changé la classification pour le stade 1. Maintenant, il y a 1B1 et 1B2. Sur la taille tumorale, moins de 4 cm et plus de 4 cm. Parce que le volume tumoral, en l'absence d'atteinte des paramètres, c'est en lui seul un élément pronostic.

Et puis vous avez le carcinome C, tendons au-delà de l'utérus, mais sans atteinte des parois pelviennes. Le stade 2A, c'est l'extension au niveau du vagin. Et le stade 2B, c'est l'envahissement de moins d'un des paramètres.

C'est toujours l'atteinte des paramètres. C'est beaucoup plus péjoratif que l'atteinte du vagin. Le stade 3A, c'est l'extension à la paroi pelvienne, ou un tiers inférieur du vagin, ou hydronephrose.

Le stade 3A, c'est l'extension au tiers inférieur du vagin, sans atteinte de la paroi. Et le stade 3B, c'est l'extension jusqu'à la paroi pelvienne, ou l'urétéro, hydronephrose, ou rein muet. Et le stade 4A, c'est l'atteinte de la vicié au rectum.

Et le stade 4B, c'est les métastases à distance. Personnellement, je n'ai jamais été convaincu de ce stade 4, parce que l'atteinte de la vicié au rectum, on peut toujours faire la radiochimiothérapie, ça marche, il y a des patients qui sont guéris, mais quand il y a des métastases à distance, c'est presque la mort certaine dans les six mois qui suivent, parce que ce sont des tumeurs qui ne sont pas hypersensibles à la chimiothérapie, mais au niveau du pelvis, chimio plus la radiothérapie, ça donne de bons résultats même pour ce stade 4. Alors, quels sont les facteurs pronostiques ? Le premier facteur, c'est la profondeur de l'invasion. Le risque de récurrence augmente avec la profondeur de l'invasion, le taux de décès augmente avec la profondeur de l'invasion.

Et puis surtout, dans le micro-invasif et les stades précoces, on se pose la question de ce qu'on doit faire pour un curage ganglionnaire, donc c'est les embols vasculaires ou lymphatiques. La présence d'embols vasculaires ou lymphatiques, ça engendre un sur-risque d'atteinte ganglionnaire, et l'atteinte ganglionnaire, c'est un élément pronostic très péjoratif dans le cancer du corps. Quand vous avez une atteinte ganglionnaire, c'est de mauvais pronostic par rapport au reste, parce qu'il y a un grand risque d'avoir une récurrence de la maladie ou des métastases à distance quand vous avez une atteinte lymphatique.

Et puis, dans les cancers infiltrants, c'est le stade de la figue, donc plus on évolue dans le stade, plus il y a un taux d'échec de maîtrise de la maladie au niveau pelvien, et plus il y a un risque d'avoir des métastases à distance, et le taux de survie est inversement proportionnel au stade. Et puis, plus la tumeur est volumineuse, malgré la présence d'autres éléments pronostiques meilleurs, favorables, juste que le volume impacte la survie. C'est pourquoi on a scindé les différents stades en fonction de ce que la tumeur fait, moins de 4 centimètres ou au-delà de 4 centimètres.

Et puis, l'envahissement ganglionnaire, c'est le maître facteur pronostique, qui a un impact péjoratif sur la survie. C'est juste pour vous dire, à un moment donné, on faisait obligatoirement, même pour une patiente candidate à RCC, radiochimie concomitante, on n'avait pas une idée sur le statut ganglionnaire. Donc sur ces patientes-là, on faisait une celluloscopie pour faire le curage, et étudier les ganglions en histologie, pour ce qu'on appelle un pre-surgery, c'est-à-dire

qu'on va faire de la chirurgie rien que pour stratifier correctement, parce que l'atteinte ganglionnaire, c'est un élément pronostique très important.

Donc on a vu le bilan d'extension, la classification, quels sont les moyens. Les moyens pour le traitement, c'est essentiellement la chirurgie et la radiochimie concomitante, et la chirurgie fait partie de la radiothérapie. Alors le but de la chirurgie, c'est l'exercice de la tumeur et éventuellement de l'extension du cœur régional.

La chirurgie pour des cas très localisés, donc pour les lésions non-invasives, pré-invasives, précancéreuses, c'est-à-dire les lésions de bas grade et les lésions de haut grade. Si je suis une patiente qui désire avoir des enfants, on doit garder l'utérus et souvent on fait une cône, on va enlever une cône. C'est un moyen tout d'abord diagnostique pour ne pas passer à côté d'une invasion et c'est un moyen qui peut être secondairement thérapeutique en cas où la lésion n'est pas invasive et on a passé en zone saine.

Donc c'est un moyen aussi thérapeutique. Puis vous avez l'amputation intravaginale du cœur, on va enlever un peu plus que la cônisation, on va enlever le cœur et souvent cette amputation, on la fait après la cônisation, c'est-à-dire qu'on fait la cônisation et on va trouver les marges qui ne sont pas saines. À ce moment-là, je vais étendre l'exérèse vers le haut, donc je peux faire complètement une amputation.

Puis en cas d'invasion, pour un stade précoce 1B1, et la patiente désire garder l'utérus parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle est très jeune, elle n'a pas d'enfant et elle a un cancer invasif, mais très précoce, à ce stade 1B1, c'est-à-dire une tumeur localisée au niveau du col et qui fait moins de 4 centimètres, mais surtout moins de 2 centimètres parce qu'on a vu avec le volume qu'il y a un risque de garder l'utérus avec une tumeur de 4 centimètres. Donc pour des tumeurs moins de 2 centimètres, chez des femmes qui désirent encore avoir des grossesses, on peut faire ce qu'on appelle la trachélectomie. La trachélectomie élargie.

Qu'est-ce que ça veut dire la trachélectomie ? C'est-à-dire qu'on va enlever tout le col jusqu'au niveau de l'isme, mais aussi on va aller faire, comme dans le Wertheim, comme dans la trachélectomie élargie, on va décroiser l'artère utérine avec l'urtère. Donc c'est ce qu'on va laisser uniquement le corps utérin et puis on va enlever une bonne partie du vagin et on va faire aussi l'infadélectomie, un curage pelvien. Tout ça pour préserver la fécondité.

Puis vous avez les hystélectomies pour un cancer invasif. Cette hystélectomie peut être faite d'emblée, avant la radiochimie, pour des stades précoces. Actuellement, elle est proposée uniquement pour les stades 1B1, et surtout pour des tumeurs de moins de 2 cm.

Là, c'est la seule fois où la patiente a le choix entre la chirurgie première ou la radiochimiothérapie. C'est pour les cas vraiment précoces. C'est le stade 1B1.

Puis cette hystélectomie peut être proposée en association avec la radiochimie. On commence

avec la radiochimie pour diminuer le volume tumoral et proposer une chirurgie par la suite. La chirurgie pour le cancer du col utérin, vous allez voir, c'est l'Overtime ou l'ACHE.

Moi, je préfère la colpo-hystérectomie élargie avec l'infadélectomie pelvienne. Colpo-hystérectomie élargie avec l'infadélectomie pelvienne. C'est la chirurgie type pour le cancer du col.

Il faut le marquer. Si vous entendez ACHE, c'est adéno. C'est relatif à quoi ? Les gonglions.

Adéno, c'est les gonglions. Colpo, oui. Le col.

Colpo, c'est le vagin. Adéno, gonglion, colpo, c'est le vagin, c'est une tranche vaginale de deux à trois centimètres. Hystérectomie élargie.

C'est quoi la majorité. Voilà, élargie au paramètre, d'accord ? On ne parle pas des annexes. Donc, élargie, c'est élargie au paramètre.

Et quand on dit élargie au paramètre, c'est que ça suppose, vu le rapport entre l'artériothérine qui descend et qui décrit une crosse pour remonter le long du bord latéral de l'utérus, vous avez l'urtère qui descend en bas, en avant et en dedans pour rejoindre la vessie. Et au niveau du paramètre, ils se croisent, l'artériothérine et l'urtère. Donc, on doit préserver l'urtère, bien évidemment.

Et enlever l'artériothérine, c'est un décroisement entre les deux éléments pour faire une hystérectomie élargie. Donc, hystérectomie élargie est égale à un décroisement entre l'artériothérine et l'urtère. Et c'est pour enlever le paramètre.

Et puis, pour enlever le paramètre, c'est pourquoi il y a différents types d'hystérectomies en fonction de l'extension de cette chirurgie vers la paroi latérale. Donc, c'est pourquoi ces hystérectomies de type 1 à type 5, c'est les hystérectomies de type bi-vert, en fonction de la profondeur de l'atteinte. Donc, ce qu'il faut retenir pour une chirurgie dans le cas du col, c'est la colpo-hystérectomie élargie au paramètre avec l'infadélectomie.

Vous avez ce qu'on fait, l'anexectomie, l'ovariectomie. Alors, les indications sont limitées de l'anexectomie. On peut faire la CHE, le Vertein, sans toucher les ovaires.

Dans le cas où le cancer ne s'adresse pas aux adénocarcinomes, aux carcinomes épidermoïdes, à des femmes jeunes, moins de 40 ans, et pour le stade précoce 1B1, au-delà, on ne garde pas les annexes. Et puis, il faut faire une transposition des ovaires, c'est-à-dire les ovaires qui sont au niveau du pelvis. On risque d'irradier ces ovaires.

5° suffit pour tuer les ovaires. On va les mettre au niveau des gouttières paréthocoliques, ce qu'on appelle la transposition des ovaires. Les ovaires sont situées au niveau des champs d'irradiation, on va les mettre au niveau des gouttières paréthocoliques.

C'est la transposition des ovaires qui s'adresse à des femmes jeunes, moins de 40 ans, à des carcinomes épidermoïdes inférieurs au stade 1B1. On a pu faire aussi ce type d'anexectomie, on peut le faire soit par la parotomie, soit par celuloscopie, et même par voie basse, par voie vaginale. Tout ça, on peut le faire.

Et puis, vous avez les exonérations pelviennes, les pelvectomies. Quand on fait la dose max de radiothérapie, la patiente est récidive. Il n'y a aucun moyen pour la guérir, pour rattraper la récidive que ça, c'est l'exonération.

C'est-à-dire qu'on va enlever les torus, les annexes, et soit on fait une pelvectomie totale, c'est d'enlever la vessie et le rectum, et on fait un bricard sur terre pour les aboucher au niveau du côté droit, et l'intestin au niveau du côté gauche, et il y a une stomie définitive. C'est pourquoi les patients n'acceptent pas ce traitement lourd, parce que c'est le seul moyen pour les sauver, mais très peu de patients vont accepter ça. C'est pourquoi personnellement, on en fait une par an ou deux ans, alors que dans ces situations de récidive, après la radiothérapie chimique et même la chirurgie, le seul moyen qui peut sauver ces patients, c'est ça, mais malheureusement ils refusent toujours, malgré qu'on insiste sur le côté qu'ils vont avoir des fistules partout, donc il y a une dégradation incroyable, ils vont mourir dans la souffrance, les fistules et tout ça.

J'essaie de les convaincre qu'il vaut mieux avoir du caca qui sort d'un trou ici plutôt que par le pelvis. Malheureusement, c'est des femmes qui vont mourir dans des situations catastrophiques. C'est pourquoi il faut éviter ce cancer et éviter les stades avancés.

On a parlé de l'anexectomie, l'infanténectomie, la conservation ovarienne, voilà les indications. Après la chirurgie, on va analyser la pièce opératoire pour voir la taille du moral, les belles gestions, le stade incontournable, c'est très important. Avec cette chirurgie, souvent quand il y a une association radiochimique puis chirurgie, il y a une mortalité de 0 à 30%, une comorbidité, il y a beaucoup de complications urinaires, en particulier les fistules, les sténoses, qui peuvent apparaître même très loin du traitement.

Et quand on fait de l'infanténectomie, on peut avoir des lymphocèles. C'est pourquoi on ne péritonise pas, on ne ferme pas le péritoine. C'est comme ça que quand vous avez du liquide, du ganglion, il va diffuser au niveau de la grande cavité abdominale et ça va résorber rapidement.

Alors les indications, je viens de parler des indications. Les stades avancées, c'est la radiochimie concomitante. La chimie, elle n'est pas très efficace, mais elle va juste sensibiliser la tumeur pour la radiothérapie.

On rend la radiothérapie beaucoup plus efficace avec la chimiothérapie. C'est pourquoi dans les métastases, s'ils sont isolés, on peut les irradier, mais s'ils ne sont pas isolés, la chimiothérapie seule ne fait pas l'affaire du tout. Alors le pronostic, vous regardez, on passe de stade 1B à plus de 90% de guérison jusqu'à moins de 20% pour le stade 4. Ça change tout.

Alors un mot sur la vaccination. L'HPV ne touche pas uniquement le col. L'HPV touche le vagin, la vulve, le canal anal.

Le cancer du canal anal, dans 70%, est secondaire à l'HPV. Les cancers oropharyngiques, tout ça est lié à l'HPV. C'est pourquoi la place de vaccination, c'est quelque chose de très important.

Alors il faut la faire avant les rapports, normalement. C'est pourquoi il faut la faire chez l'enfant, entre 9 ans à 14 ans. Mais personnellement, j'ai toujours défendu l'idée qu'une fille encore vierge, qui a 25 ans, 30 ans, comme c'est le cas chez nous, ça change.

Donc il peut toujours bénéficier de la vaccination. Il n'y a pas de mal si une fille à l'âge de 30 ans n'a jamais fait de rapport, pourquoi il peut avoir sa dose, il n'y a pas de problème. Donc on a essayé par génétique de fabriquer des fragments d'ADN du virus.

C'est ça le vaccin qui va induire, en cas d'injection, une synthèse d'anticorps sérique et qui va transsuder au niveau du col utérin pour maîtriser le virus. Il y en a deux qui sont disponibles au Maroc, c'est le Gardasil et le Cervarix. Le Gardasil est efficace sur les 16 et 18 ans, qui sont responsables de la majeure partie des cancers, c'est à peu près 80%.

Le 6 et 11 ans, c'est les condylomes, les verrues. Le 6 et 11 ans, c'est les verrues. Ils ne se transforment jamais en cancers.

Les verrues, c'est le virus 16 et 11, mais c'est très handicapant pour les femmes d'avoir des verrues au niveau de la vulve, au niveau de l'anus. Ça tue leur sexualité et la vie du couple. Actuellement, pour le Gardasil, il y a ce qu'on appelle le non-avalant.

Non-avalant, c'est-à-dire qu'il y a neuf scénarios. Donc, on a rajouté d'autres scénarios à haut risque cancérigène. Le Cervarix, si on a la possibilité de faire le Gardasil, c'est mieux.

C'est pourquoi l'État marocain a acheté le Gardasil. Mais malheureusement, ils sont encore stockés depuis plus d'un an au niveau des centres de santé. Personne ne l'utilise, parce qu'il y a un grand problème.

Comment dire à des parents ? Dire à un parent comme quoi on va vacciner contre une infection sexuellement transmissible, il va dire non, ma fille ne fera jamais ça. Elle parle des rapports. C'est comme ça, les parents.

Donc, comment faire des vaccins pour des enfants entre 9 et 14 ans ? Donc, soit via l'école, il faut que les parents donnent leur accord. Mais pour expliquer à des parents, au niveau du Maroc, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est comme à l'époque du sida, où quand on commençait à donner des préservatifs partout, ça a fait un scandale au Maroc.

Donc, on a toujours cette idée de ce qui s'est passé au moment de l'apparition de la chivée. Comment convaincre les parents pour qu'ils acceptent de vacciner les enfants ? C'est tout un

débat et c'est très difficile. Les vaccins sont à Marrakech, ils sont disponibles actuellement.

Si vous en voulez, si vous êtes convaincu, allez-y. Dans les centres de santé, vous allez les trouver. Alors, est-ce qu'on va vacciner que les filles ? C'est une très bonne question.

Dans les pays avec une forte prévalence vaccinale, ils vaccinent même les garçons. Pourquoi ? Parce que les garçons sont les vecteurs, en fait. Donc, plus on vaccine les garçons, on va diminuer la circulation du virus.

Avant, on faisait trois doses espacées de deux mois. Actuellement, on sait que deux doses, c'est suffisant, mais elles doivent être espacées de six mois. On fait la première dose et six mois plus tard, on refait une deuxième dose.

Et toutes les études ont montré que le vaccin garde l'immunité. Il est stable pendant plus de 20 ans après le vaccin. Le pronostic lié au stade, les formes localisées sont plus de 90 %. Ils sont curables.

C'est un pronostic prononcé pour les améliorer. Le diagnostic précoce, métrologie, pensée conservatrice, mais surtout le dépistage. La prise en charge doit être faite en multidisciplinaire pour proposer la meilleure solution.

Et puis, surtout, il faut penser à vacciner. Malheureusement, on a ce problème d'information, de communication. On n'arrive pas à le résoudre.

Mais de temps en temps, il y a quand même des femmes qui ramènent leurs filles. Souvent, des filles qui étudient à Victor Hugo, les patients sont un peu cultivés. Mais quand ils ramènent la fille, c'est déjà qu'elle a commencé à faire des rapports.

Elle a peur, elle commence à avoir peur, elle ramène pour le vaccin. Donc, c'est le Maroc. C'est très difficile à communiquer dans ce sens.

Mais je pense que si on instaure la vaccination au Maroc, ça n'évite pas le dépistage. Dans les pays occidentaux, ils font les deux. Mais quand même, vacciner et lâcher la population, je suppose, plutôt que de ne rien faire.

À bientôt.